

*"Buscando la sensatez en Medicina"*

*"Si la sensatez claudica ante lo inmediato o violento, seremos conducidos por los menos aptos"*

Carlos A. Yelin.

*"¿Que tipo más sensato!"*

*Esta afirmación, que pretende definir con exactitud, y sin precisar una aclaración, a un grupo muy exclusivo de la población, resulta en un análisis más exhaustivo, de una complejidad difícil de admitir.*

*Pareciera que ser sensato, configura una definición adecuadamente acotada. Pero si hacemos el ejercicio de preguntar a quienes nos rodean, (lo que sugiero), que entienden por sensatez, nos asombrará que la acepción tiene variadas interpretaciones. Casi todas serán una aproximación al significado que le adjudica la Real Academia de Letras, pero serán igualmente incompletas.*

*Imaginamos entonces, que el término es abarcativo, e incluye varios conceptos, ligados entre sí, que al hacer una sumatoria, configuran la verdadera dimensión de lo sensato.*

*Si en un segundo paso, preguntamos si una situación, o circunstancia determinada, se adapta al adjetivo mencionado, la mayoría responde adecuadamente.*

*Por ejemplo, si le preguntamos a un excedido de peso, ¿es aconsejable hacer una sola comida abundante, para reducir el peso?*

*Aunque se tratare de una persona que largamente cultiva ése hábito, y lo tranquiliza el largo ayuno liberador de culpa, el obeso y todos van a coincidir en que se trata de un hábito desprovisto de sensatez.*

*Cambiando el protagonista, si a un médico, le preguntamos, ¿Es correcto formular recomendaciones a las que el propio profesional en su vida cotidiana no adhiere?*

*De nuevo, aparecerá la respuesta negativa, desprovista de dudas, y contundente.*

*En ambos ejemplos, surgirá la sensatez de la respuesta, pero no necesariamente, la aplicación práctica de lo pactado en el razonamiento.*

*Buscamos con estos ejemplos, iniciar la reflexión, para lograr que la simple respuesta, casi siempre objetiva, se transforme en un ejercicio, y no solo seamos sensatos contestando, sino en la práctica diaria de nuestra identidad como médicos, o como pacientes.*

*Personalmente asociamos el término, a la prudencia, tanto en el ejercicio de nuestros cuidados personales, siendo pacientes, como en las recomendaciones a formular en nuestro consultorio. Pero ser prudente no engloba adecuadamente lo que sugiere el término en cuestión. Se nos ocurre como algo*

*pasivo, que habla del equilibrio necesario para tomar una decisión; pero insuficiente para el aspecto*

*actitudinal o fáctico. Se podría completar con: "obrar en forma atinada al contexto de la situación, buscando resultados que se ajusten al sentido común". Como verán, la amplitud de éstas consideraciones, si bien, ayudan a entender lo que pretendemos definir, convierten a la sensatez en una virtud de difícil logro, y no pensamos que se trate de una exquisitez del comportamiento, sino de un ejercicio a desarrollar a través de una práctica recurrente, que se habitúe a respetar los límites y que valore los logros que se obtienen por ejercerla.*

*Si empleamos ejemplos concretos, destinados a agilizar el entendimiento de la cuestión, podríamos interrogarnos:*

- 1) ¿Es más sensato emprender una dieta, que lógicamente comienza y termina, o desarrollar una educación alimentaria permanente para equilibrar el peso?*
- 2) ¿Es más sensato suspender una medicación por decisión personal, ante la sospecha de efectos adversos, o previamente obtener el aval del profesional que la indicara?*
- 3) ¿La sensatez en las indicaciones médicas deben respaldarse en la experiencia del profesional, o en las comprobaciones científicas (cuantitativas) y los resultados logrados en el paciente? (cualitativos)*
- 4) ¿Es sensato preocuparnos porque en la farmacia, nos encontraron 160 mm, (16 para la forma coloquial de comentar) aunque el médico nos haya aclarado que nuestro corazón, está bien, nuestras arterias del cuello y del fondo de ojo, y el electrocardiograma están perfectos? La presión arterial, ¿es un número, o una entidad clínica a ser evaluada en su totalidad?*

*Los ejemplos pueden ser interminables, según el perfil de la actividad del médico, y las necesidades del paciente.*

*Es probable que lo que pretendemos instalar en la actitud de los dos protagonistas, médico y paciente, sea el profesional, el que tiene la mayor responsabilidad debido a la posición que ejerce en los correspondientes roles de la "alianza terapéutica".*

*Pero no cometamos la imprudencia de aislar a la medicina del contexto social, en nuestro país y en el mundo. Las noticias más atractivas para el que lee, mira o escucha, se vinculan a quienes de alguna manera adquieren la fama de ingresar al libro guiness, por trivialidades que no debieran interesar a nadie. Cuando se logra en la ciencia atravesar lo que constituía un límite, siempre nos pareció valioso. Los que tenemos una larga trayectoria en la profesión, hemos presenciado la curación de enfermedades antes fatales, o la aparición de la cirugía laparoscópica, o el progreso sin techo de los estudios por imágenes. Respetamos entonces a los que lograron perforar lo que constituía antes una limitación en la ciencia médica. También en el deporte los desafíos pueden ser beneficiosos. Pero pensamos que la saturación mediática de ésos logros es un estímulo a la temeridad. La presencia de los jóvenes en los accidentes y desgracias cotidianas define el estímulo al desarrollo a la temeridad. La aparición de los "deportes extremos" y su mediática divulgación incrementada. El paso siguiente es la temeridad como comportamiento social, que en los*

*desposeídos se transforma en robos, asaltos y configura la problemática de la inseguridad.*

*Cuando en la formación del estudiante de medicina, incrementemos el sentido de la prudencia en el contacto con el paciente, y promovamos la tendencia a una permanente reflexión sobre la adecuación de actitud según la personalidad del sufriente, estaremos delineando el perfil sensato del futuro médico. No podemos dejar de enseñarles la jerarquía de las investigaciones que cuantifican los resultados de los extensos estudios de la medicina "basada en la evidencia", pero sin perder de vista que lo que se hizo en una multitud, debe ser aplicado en un sujeto que jamás debiera reducir su calidad de vida para someterse a los dictámenes terapéuticos o preventivos de manera taxativa. En los docentes, estimulemos la tendencia socrática, (dialoguista) para obtener el desarrollo del intercambio del conocimiento. En ese contexto, seguramente vamos a hacer crecer la disposición a la sensatez en el mecanismo del aprendizaje.*

*En un mundo en donde nos parece que crece lo insensato, la inmediatez, y la imprudencia, se aplaude y admira a los que logran atravesar los límites y los estándares hasta configurar mediáticamente una saturación, la lucha para recomponer el pensamiento, buscando la serenidad, la reinstalación de los valores auténticos de la vida, probablemente estaremos construyendo los cimientos de la anhelada sensatez.*